Клинические рекомендации

# Мигрень

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **G43** — Мигрень<br>**G43.0** — Мигрень без ауры [простая мигрень]<br>**G43.1** — Мигрень с аурой [классическая мигрень]<br>**G43.2** — Мигренозный статус<br>**G43.3** — Осложненная мигрень<br>**G43.8** — Другая мигрень<br>**G43.9** — Мигрень неуточненная<br>**G44.0** — Синдром «гистаминовой» головной боли<br>**G44.1** — Сосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках<br>**G44.4** — Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках |
| Пациенты | взрослые |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года |
| Разработчик | Всероссийское общество неврологов; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"; Межрегиональная общественная организация "Российское общество по изучению головной боли" |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/295_4 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Основные положения** 3

**2. Клиническая картина и классификация** 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 4

**3. Диагностика** 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Лекарственно-индуцированная головная боль 5

3.3 Жалобы и анамнез 6

3.4 Физикальное обследование 6

3.5 Лабораторные исследования 6

3.6 Инструментальные исследования и консультации 7

3.7 Дневник головной боли 7

3.8 Дифференциальная диагностика 7

**4. Лечение** 8
4.1 Купирование приступа 8
4.2 Мигренозный статус 10
4.3 Профилактическая терапия 10
4.4 Лечение мигрени с лекарственно-индуцированной головной болью 12
4.5 Немедикаментозное лечение 13
4.6 Медицинская реабилитация 13
**5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации** 13
5.1 Диспансерное наблюдение 13
5.2 Показания к госпитализации 14
**6. Источник и актуальность** 14
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 14

## 1. Основные положения

- Мигрень — первичная головная боль: приступы пульсирующей односторонней боли длительностью **4–72 часа** с повышенной чувствительностью к свету и звуку, тошнотой и/или рвотой. Обычно начинается **до 20 лет**; женщины болеют в 2,5–3 раза чаще.
- Диагноз клинический — по критериям МКГБ-3. При типичной мигрени дополнительные исследования не нужны; при редких формах ауры, осложнениях и «сигналах опасности» показаны МРТ головного мозга и МР-ангиография, консультации офтальмолога, оториноларинголога, психотерапевта.
- При мигрени со стволовой аурой наряду со зрительными, чувствительными и речевыми нарушениями возникают обратимые стволовые симптомы: дизартрия, головокружение, шум в ушах, снижение слуха, диплопия, атаксия, изменение сознания.
- Лёгкий и средний приступ купируют анальгетиками и НПВП (препарат первого выбора — ибупрофен 400 мг), тяжёлый — триптанами **в первые 30 минут** от начала боли. Профилактика показана при **3 и более** тяжёлых приступах или **8 и более** днях с болью в месяц.

## 2. Клиническая картина и классификация

### 2.1 Определение

Мигрень (М) — первичная форма головной боли (ГБ), проявляющаяся приступами пульсирующей односторонней боли продолжительностью **4–72 часа**, которая сопровождается повышенной чувствительностью к свету, звуку, тошнотой и/или рвотой.

Мигрень обычно возникает **до 20 лет**; в детстве чаще у мальчиков, у взрослых женщины болеют в 2,5–3 раза чаще. Максимум частоты и интенсивности приступов — в 35–45 лет, после 55–60 лет течение облегчается или приступы прекращаются.

### 2.2 Этиология и эпидемиология

Мигрень — хроническое нейроваскулярное заболевание с наследственной предрасположенностью. Основное звено патогенеза — периодическое периваскулярное нейрогенное воспаление сосудов твёрдой мозговой оболочки при повышенной возбудимости коры и тригеминоваскулярной системы. Механизм ауры — распространяющаяся корковая депрессия.

Распространённость мигрени в Европе и США — около 14%, в России за год — 15,9–20,8%.

### 2.3 Классификация

Две основные формы: мигрень без ауры — до 80% случаев, мигрень с аурой — до 20%. Реже встречаются мигрень со стволовой аурой (ранее «базилярная»), ретинальная и гемиплегическая мигрень.

**Классификация мигрени (МКГБ-3, 2018)**

1. мигрень без ауры;
2. мигрень с аурой: с типичной аурой, со стволовой аурой, гемиплегическая, ретинальная;
3. хроническая мигрень;
4. осложнения мигрени: мигренозный статус, персистирующая аура без инфаркта, мигренозный инфаркт, аура — триггер эпилептического припадка;
5. возможная мигрень;
6. эпизодические синдромы: синдром циклических рвот, абдоминальная мигрень, доброкачественное пароксизмальное головокружение, доброкачественный пароксизмальный тортиколлис.

### 2.4 Клиническая картина

Мигрень без ауры — повторяющиеся однотипные приступы интенсивной, чаще односторонней пульсирующей боли, которая усиливается при нагрузке; приступ длится **от 4 часов до 3 суток**.

1. **локализация** — преимущественно висок, глаз, темя; нередко начало в затылке
2. **сопровождающие симптомы** — тошнота, рвота, повышенная чувствительность к свету и звукам

Частота при эпизодической мигрени — от 1 дня в год до 14 дней в месяц (в среднем 2–4), при хронической — **15 и более дней в месяц**.

При мигрени с аурой фазе боли предшествуют преходящие неврологические нарушения. При типичной ауре — полностью обратимые зрительные, чувствительные и/или речевые симптомы без двигательных и стволовых; в редких случаях боль после ауры не развивается.

1. **мигрень со стволовой аурой** — два или более обратимых стволовых симптома: дизартрия, головокружение, шум в ушах, снижение слуха, диплопия, атаксия, изменение уровня сознания
2. **гемиплегическая мигрень** — чрезвычайно редкая, почти всегда наследственная; обратимые двигательные нарушения **до 72 часов**
3. **ретинальная мигрень** — обратимые односторонние зрительные феномены (вспышки, скотомы), подтверждённые исследованием полей зрения во время приступа

**Наиболее частые триггеры приступа**

1. стресс или расслабление после стресса, тревога, депрессия, переутомление;
2. изменения погоды;
3. менструация, овуляция, эстрогенсодержащая гормональная терапия и оральные контрацептивы;
4. голод, некоторые продукты (сыр, шоколад, орехи, копчёности, куриная печень, авокадо, цитрусовые, кофеинсодержащие продукты), алкоголь, особенно красное вино;
5. недостаток или избыток сна, духота, аэробная нагрузка, яркий или мерцающий свет, шум, пребывание на высоте.

1. **хроническая мигрень** — 15 и более дней с болью в месяц; коморбидные психические расстройства, нарушения сна, снижение эффективности средств для купирования
2. **мигренозный статус** — изнуряющий приступ **более 72 часов** с ремиссиями до 12 часов
3. **персистирующая аура без инфаркта** — симптомы ауры **более 1 недели** без признаков инфаркта мозга
4. **мигренозный инфаркт** — симптомы ауры **более 60 минут** с ишемическим повреждением, подтверждённым нейровизуализацией
5. **аура — триггер эпилептического припадка** — припадок во время приступа мигрени с аурой или **в течение 1 часа** после него

## 3. Диагностика

### 3.1 Критерии диагноза

Всем пациентам с жалобой на головную боль проводится клиническая диагностика мигрени по критериям МКГБ-3.

**Диагностические критерии мигрени без ауры**

1. A. Не менее 5 приступов, отвечающих критериям B–D.
2. B. Продолжительность **4–72 часа** без лечения или при его неэффективности.
3. C. Не менее 2 из 4 характеристик: односторонняя локализация; пульсирующий характер; средняя или выраженная интенсивность; усиление от обычной физической активности.
4. D. Не менее 1 симптома: тошнота и/или рвота; фотофобия и фонофобия.
5. E. Боль не соответствует лучше другому диагнозу МКГБ-3.

**Диагностические критерии мигрени с аурой**

1. A. Не менее 2 приступов, отвечающих критериям B и C.
2. B. Один или более полностью обратимых симптомов ауры: зрительные, сенсорные, речевые, двигательные, стволовые, ретинальные.
3. C. Не менее 3 из 6 характеристик: постепенное нарастание симптома **более 5 минут**; последовательное возникновение симптомов; каждый длится **5–60 минут**; хотя бы один симптом односторонний; хотя бы один позитивный; боль во время ауры или **в течение 60 минут** после неё.
4. D. Другой диагноз МКГБ-3 не подходит в большей степени.

Ауру не путают с продромальными симптомами за несколько часов до приступа: повышенной чувствительностью к свету, звукам и запахам, изменением аппетита, жаждой, эмоциональным возбуждением или разбитостью.

**Диагностические критерии хронической мигрени**

1. A. Головная боль **15 и более дней в месяц** на протяжении **3 и более месяцев**.
2. B. В анамнезе не менее 5 приступов мигрени без ауры и/или с аурой.
3. C. **8 и более дней в месяц** в течение 3 месяцев боль соответствует мигрени или купируется триптанами либо эрготамином.
4. D. Другой диагноз МКГБ-3 не подходит в большей степени.

Число дней с болью за 3 месяца устанавливают расспросом и по дневнику; важный критерий — типичные приступы эпизодической мигрени в начале заболевания.

### 3.2 Лекарственно-индуцированная головная боль

Частая эпизодическая (более 10 дней с болью в месяц) и хроническая мигрень могут сочетаться с лекарственным абузусом — ведущим фактором хронизации. ЛИГБ диагностируется при головной боли **более 15 дней в месяц** у пациента с первичной головной болью и регулярном злоупотреблении препаратами для купирования **более 3 месяцев**.

ЛИГБ проявляется диффузной монотонной, чаще утренней или ночной болью, нарастающей с прекращением действия препарата. Наибольший риск — у препаратов с кодеином, барбитуратами и кофеином; при выявлении ЛИГБ выставляются два диагноза.

**Формы ЛИГБ по числу дней приёма**

| Препараты злоупотребления | Число дней с приёмом в месяц (3 месяца и более) |
|---|---|
| эрготаминсодержащие препараты, триптаны | 10 и более |

| Препараты злоупотребления | Число дней с приёмом в месяц (3 месяца и более) |
|---|---|
| парацетамол, НПВП, ацетилсалициловая кислота, другие анальгетики и антипиретики | 15 и более |
| опиоиды, анальгетики с компонентами разных классов, комбинации нескольких классов, другие препараты | 10 и более |

### 3.3 Жалобы и анамнез

**Типичные жалобы**

1. повторяющиеся приступы односторонней пульсирующей боли в лобно-височной или теменной области;
2. интенсивность средняя или выраженная — более 7 баллов по ВАШ;
3. продолжительность **4–72 часа**, усиление от обычной физической активности;
4. тошнота и/или рвота, повышенная чувствительность к свету и звукам;
5. при ауре — нарушения, нарастающие 5–20 минут и длящиеся **не более 60 минут**.

**Характерный анамнез**

1. первые приступы **до 20 лет**;
2. аналогичные головные боли у родственников;
3. урежение или прекращение приступов во время беременности и в менопаузе;
4. ухудшение при стрессе, депрессии, тревоге, злоупотреблении обезболивающими, приёме оральных контрацептивов, в преклимаксе.

У всех пациентов выявляют коморбидные нарушения — прежде всего депрессию, тревожные расстройства, нарушения сна и другие болевые синдромы: они утяжеляют течение и способствуют хронизации.

### 3.4 Физикальное обследование

Исследуется неврологический статус для исключения органической симптоматики; при типичной мигрени изменений нет.

**Возможные находки**

1. снижение настроения, тревожность;
2. вегетативные нарушения, симптом Хвостека I–III степени;
3. напряжение и болезненность перикраниальных мышц.

При менингеальных, общемозговых или очаговых знаках проводятся дополнительные исследования.

### 3.5 Лабораторные исследования

При типичной картине и нормальном неврологическом статусе лабораторные исследования не рекомендуются. При атипичной картине, «сигналах опасности» или осложнениях выполняются общий (клинический) анализ крови, исследования общевоспалительных реакций и коагулограмма.

### 3.6 Инструментальные исследования и консультации

Без атипичных черт и неврологических нарушений инструментальные исследования не рекомендуются; единичные субклинические очаги в белом веществе на МРТ маркерами мигрени не являются.

При редких формах ауры и осложнениях мигрени для исключения аневризмы, артериовенозной мальформации, диссекции сонных артерий выполняются МРТ головного мозга, МР-ангиография, МР-венография; при невозможности МРТ — КТ и КТ-ангиография.

При нетипичном течении или «сигналах опасности» — МРТ и МР-ангиография, при необходимости консультации офтальмолога, оториноларинголога, психотерапевта.

**«Сигналы опасности»**

1. боль, впервые возникшая после 50 лет, или изменившая течение;
2. «громоподобная» боль, нарастающая до 10 баллов по ВАШ **за 1–2 секунды**;
3. строго односторонняя боль;
4. прогрессивно ухудшающаяся боль без ремиссий;
5. внезапная, необычная для пациента боль;
6. атипичная аура: необычные нарушения и/или продолжительность **более 1 часа**;
7. изменения сознания или психические нарушения;
8. очаговые знаки и симптомы системного заболевания: лихорадка, сыпь, ригидность шейных мышц, артралгии, миалгии;
9. признаки внутричерепной гипертензии;
10. отёк диска зрительного нерва;
11. ВИЧ-инфекция, онкологическое, эндокринное, системное заболевание или травма головы в анамнезе;
12. дебют во время беременности или в послеродовом периоде;
13. неэффективность адекватного лечения.

### 3.7 Дневник головной боли

Дневник **в течение 1–3 месяцев** до осмотра позволяет установить характеристики приступа, число дней с болью и с приёмом обезболивающих, отличить приступ мигрени от эпизода ГБН и выявить лекарственный абузус.

### 3.8 Дифференциальная диагностика

Чаще всего мигрень дифференцируют с ГБН, кластерной головной болью, хронической пароксизмальной гемикранией и цервикогенной головной болью.

**Мигренеподобная боль возможна при**

1. транзиторной ишемической атаке и инсульте;
2. гигантоклеточном артериите;
3. диссекции артерий, аневризмах, артериовенозных мальформациях;
4. церебральном венозном тромбозе;
5. опухоли головного мозга;
6. субарахноидальном кровоизлиянии;
7. антифосфолипидном синдроме и тромбофилиях;
8. эпилепсии;
9. синдромах MELAS и CADASIL.

Эти заболевания всегда проявляются неврологическим дефицитом или другими «сигналами опасности». Сочетающиеся формы головной боли вносятся в диагноз.

Для ауры типично постепенное нарастание симптомов на одной стороне тела за 10–30 (до 60) минут — «марш» со сменой позитивных и негативных симптомов.

1. зрительные феномены: мерцание, зигзаги, тёмные пятна, скотомы;
2. затем парестезии и онемение от кисти к плечу и лицу;
3. далее речевые расстройства;
4. в конце ауры — мигренозная боль.

При ТИА нарушения негативные и возникают остро и одновременно; боль не характерна, мигрени в анамнезе, как правило, нет.

Хроническую мигрень дифференцируют с хронической ГБН, новой ежедневной персистирующей головной болью и гемикранией континуа; опираются на ранний анамнез — типичные приступы эпизодической мигрени, наследственность, мигренозные триггеры, облегчение во время беременности.

Мигрень плохо диагностируется: вместо неё ставят дисциркуляторную энцефалопатию, остеохондроз шейного отдела, вегетососудистую дистонию, цервикогенную головную боль, боль при артериальной гипертензии — из-за трактовки неспецифических изменений УЗДГ и рентгенографии как органических. Неверный диагноз ведёт к назначению психостимуляторов и ноотропов, которые способствуют хронизации.

---

## 4. Лечение

Лечение включает три подхода: поведенческую терапию, купирование приступов и профилактическое лечение. Цели — уменьшение частоты и тяжести приступов и числа принимаемых обезболивающих, коррекция коморбидных нарушений, профилактика хронизации.

**Поведенческая терапия**

1. разъяснение доброкачественной природы мигрени;
2. обоснование нецелесообразности дополнительных исследований;
3. роль провокаторов приступов и необходимость их избегать;
4. факторы хронизации: стресс, лекарственный абузус, коморбидные нарушения;
5. цели лечения и действие профилактических препаратов;
6. при злоупотреблении обезболивающими — временный отказ от них и строгий контроль их числа.

### 4.1 Купирование приступа

1. **лёгкий приступ** — пациент способен выполнять привычную домашнюю и профессиональную работу
2. **приступ средней тяжести** — эти виды деятельности существенно ограничены
3. **тяжёлый приступ** — необходим постельный режим

Терапию назначают в зависимости от тяжести приступа и степени дезадаптации.

**Купирование лёгкого и среднего приступа**

| Препарат | Разовая доза | УУР |
|---|---|---|
| **ацетилсалициловая кислота — препарат выбора** | 1000 мг внутрь | A |
| **ибупрофен — препарат выбора** | 400 мг внутрь | A |
| **напроксен — препарат выбора** | 500 мг внутрь | C |

| Препарат | Разовая доза | УУР |
|---|---|---|
| **парацетамол — препарат выбора** | 1000 мг внутрь | A |
| **диклофенак — препарат выбора, порошок для раствора внутрь** | 50 мг | A |
| **кетопрофен** | 75 или 150 мг внутрь | B |
| **ацетилсалициловая кислота + кофеин + парацетамол** | 2 таблетки внутрь | B |

### Принципы применения анальгетиков и НПВП

1. НПВП и ацетилсалициловая кислота эффективнее парацетамола;
2. препарат первого выбора — ибупрофен 400 мг: наименьший риск желудочно-кишечных осложнений;
3. для контроля приёма ведётся дневник;
4. учитывают действие НПВП на ЖКТ и риск кровотечений;
5. не рекомендуются метамизол натрия (агранулоцитоз), опиоиды, препараты с кодеином или барбитуратами (абузус и ЛИГБ);
6. быстрорастворимые формы действуют быстрее: кетопрофен (лизиновая соль) 40 или 80 мг, диклофенак 50 мг в порошке.

При тошноте и рвоте вместе с анальгетиком применяют противорвотные средства: они уменьшают гастростаз и улучшают всасывание обезболивающих.

1. метоклопрамид: 10 мг внутримышечно или 10–20 мг внутрь
2. домперидон: 10 мг 3 раза в сутки внутрь

При тяжёлых приступах и неэффективности анальгетиков и НПВП применяют триптаны; они наиболее эффективны и могут применяться и при приступах средней тяжести.

### Триптаны для купирования приступа

| Триптан | Разовая доза |
|---|---|
| **суматриптан** | 50 или 100 мг внутрь |
| **элетриптан** | 40 или 80 мг внутрь |
| **золмитриптан** | 2,5 или 5 мг внутрь или назальный спрей |
| **ризатриптан** | 10 мг внутрь или диспергируемые в полости рта таблетки |

### Правила приёма триптанов

1. в самом начале приступа — **в первые 30 минут** от начала боли;
2. не меньше суматриптан 50 мг, элетриптан 40 мг, золмитриптан 2,5 мг, ризатриптан 10 мг;
3. при мигрени с аурой — не во время ауры, а в конце её или в начале фазы боли;
4. не более **10 дней в месяц**; повторная доза — **через 2 часа**, не более 2 доз в сутки;
5. при неэффективности одного триптана пробуют другие.

Противопоказания: ишемическая болезнь сердца, окклюзионные заболевания периферических сосудов, неконтролируемая артериальная гипертензия, мигрень со стволовой аурой.

Наиболее безопасен при сердечно-сосудистом риске элетриптан; назальный спрей золмитриптана начинает действовать **через 15 минут** и предпочтителен при выраженной тошноте и рвоте.

При тяжёлом приступе, особенно при невозможности приёма внутрь из-за тошноты и рвоты, применяется #кеторолак 60 мг внутримышечно или 30 мг внутривенно.

### 4.2 Мигренозный статус

При мигренозном статусе применяют триптаны, если пациент не принимал их для купирования приступа.

В стационаре статус купируют парентеральным введением препаратов, выбор которых определяется картиной и тяжестью; лечение проводится в тихом затемнённом помещении.

**Купирование мигренозного статуса**

| Препарат | Разовая доза и путь введения |
|---|---|
| **метоклопрамид** | 10 мг внутривенно капельно в 50 мл раствора натрия хлорида за 20 минут |
| **#хлорпромазин** | 0,1 мг/кг внутривенно капельно |
| **#декскетопрофен** | 50 мг внутривенно |
| **#кеторолак** | 60 мг внутримышечно или 30 мг внутривенно |
| **#магния сульфат — только при статусе мигренозной ауры** | 2 г внутривенно капельно |
| **#вальпроевая кислота — не у женщин детородного возраста** | 800–1000 мг внутривенно |
| **#дексаметазон — для предотвращения возврата приступа** | 10–24 мг внутривенно |

Внутривенное введение дроперидола и галоперидола не рекомендуется из-за риска побочных реакций. Перед назначением антипсихотических средств выполняется ЭКГ (удлинённый QT — противопоказание). Парентеральное введение жидкостей показано только при повторной рвоте и дегидратации.

### 4.3 Профилактическая терапия

Профилактика показана при **3 и более** тяжёлых дезадаптирующих приступах в месяц при адекватном купировании или **8 и более днях** с болью в месяц, а также при пролонгированной ауре даже при редких приступах.

**Другие показания**

1. неэффективность или плохая переносимость средств купирования;
2. хроническая мигрень;
3. лекарственный абузус, ЛИГБ;
4. мигренозный инфаркт или статус в анамнезе, мигрень со стволовой аурой, гемиплегическая мигрень;
5. тяжёлые коморбидные нарушения;
6. предпочтение пациента.

**Принципы профилактического лечения**

1. начинать с монотерапии препаратом с доказанной эффективностью, медленно повышая дозу;
2. оценивать эффект **через 3 месяца**: эффективно, если число дней с болью снизилось **на 50% и более**; ботулинотерапию — не ранее чем через 6 месяцев;
3. при эффекте — продолжать **6–12 месяцев**, затем постепенная отмена;
4. избегать избыточного приёма средств купирования (чаще 2 дней в неделю);
5. учитывать коморбидные заболевания;
6. длительность — **6 месяцев** при эпизодической и **12 месяцев** при хронической мигрени.

**Препараты для профилактики мигрени**

| Препарат | Суточная доза | УУР |
|---|---|---|
| **метопролол — первый выбор** | 100–200 мг внутрь | B |
| **пропранолол — первый выбор** | 80–160 мг внутрь | A |
| **топирамат — первый выбор; титрация с 25 мг, основная доза вечером, курс до 12 месяцев** | 100 мг, возможно до 200 мг | B |
| **ботулинический токсин типа A — первый выбор, только при хронической мигрени** | 155–195 ЕД по протоколу PREEMPT каждые 12 недель | A |
| **фреманезумаб, эренумаб — первый выбор при 4 и более днях с болью в месяц** | фреманезумаб 225 мг подкожно ежемесячно или 675 мг раз в 3 месяца; эренумаб 70 или 140 мг подкожно ежемесячно | A |
| **#атенолол — второй выбор** | 100 мг | B |
| **#амитриптилин, #венлафаксин — второй выбор** | 50–150 мг; 75–150 мг | B |
| **#кандесартан — второй выбор** | 16 мг | B |
| **#вальпроевая кислота — второй выбор, нежелательна у женщин с детородным потенциалом** | 400–1500 мг внутрь | A |

Моноклональные антитела к CGRP назначают **от 6 до 12 месяцев** и более, эффективность оценивают **через 3 месяца**; при хронической мигрени курс продлевают до 18 месяцев. Ботулотоксин вводят в 7 групп мышц головы и шеи; эффект одной процедуры сохраняется около 3 месяцев.

### 4.4 Лечение мигрени с лекарственно-индуцированной головной болью

Частая эпизодическая мигрень (8 и более дней с болью и 8–10 дней с приёмом обезболивающих в месяц) — группа риска ЛИГБ: пациентам разъясняют безопасный режим — **не чаще 2 дней в неделю, не более 8 дней в месяц**.

Для обратной трансформации хронической мигрени в эпизодическую препарат, вызвавший ЛИГБ, отменяют полностью или частично: приём обезболивающих — **не более 2 дней в неделю (8 в месяц)**.

1. **амбулаторно** — отмена анальгетиков, антипиретиков и триптанов
2. **в стационаре или дневном стационаре** — отмена опиоидов, спазмолитиков, психотропных препаратов и анальгетиков в комбинации

В период отмены лечат «рикошетную» боль и другие симптомы отмены; препараты первого выбора — кортикостероиды системного действия, НПВП, противорвотные и анксиолитики.

1. #преднизолон: 100 мг 5 дней или 60 мг с постепенным снижением на 5–10 мг каждые 3 дня в течение 1–2 недель
2. #метилпреднизолон: 500 мг внутривенно или 125 мг в 250 мл раствора натрия хлорида с #диазепамом 10 мг и эзомепразолом 40 мг внутривенно капельно 1 раз в сутки 5 дней
3. #дексаметазон: 8 мг внутривенно капельно 1 раз в сутки 5 дней
4. #целекоксиб: 400 мг в сутки внутрь 5 дней, затем снижение на 100 мг каждые 5 дней
5. метоклопрамид при рвоте: 10 мг 1 раз в сутки внутрь или внутримышечно 5–7 дней

Детоксикацию проводят **в первые 2 недели** отмены; можно применять препараты тех классов, которыми пациент не злоупотреблял. С кортикостероидами и НПВП добавляют ингибиторы протонного насоса.

Для профилактики частой эпизодической и хронической мигрени с ЛИГБ применяют топирамат (100 мг/сут, диапазон 50–200 мг, титрация с 25 мг по 25 мг в неделю), ботулинический токсин типа А (155–195 ЕД по протоколу PREEMPT) и моноклональные антитела к CGRP; профилактику предпочтительно начинать одновременно с отменой.

### 4.5 Немедикаментозное лечение

Фармакологическое лечение сочетают с немедикаментозными методами для повышения эффективности терапии.

При тревожно-депрессивных и соматоформных расстройствах — когнитивно-поведенческая терапия, психотерапия и психологическая релаксация (УУР А).

Биологическая обратная связь по частоте пульса и электромиографии мышц скальпа и шеи — обучение психологическому и мышечному расслаблению (УУР А).

Рефлексотерапия (акупунктура) — дополнительный метод профилактического лечения (УУР В).

Постизометрическая релаксация — при выраженной дисфункции перикраниальных мышц (УУР А).

Лечебная физкультура (УУР В): упражнения лёгкой интенсивности, тренировки на выносливость, скандинавская ходьба — **максимум 3–4 раза в неделю** по 20–60 минут.

Блокада большого затылочного нерва кортикостероидами и местными анестетиками — дополнительный метод (УУР С).

Высокочастотная ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция — дополнительный метод профилактики, в том числе при хронической мигрени (УУР В).

Неинвазивная электростимуляция первой ветви тройничного нерва — для купирования приступов и профилактики (УУР А).

Инвазивная нейростимуляция большого затылочного нерва — при рефрактерной хронической мигрени; направление — совместно специалистом по головной боли и нейрохирургом (УУР А).

Диетотерапия не рекомендуется; целесообразен совет исключить продукты-провокаторы: шоколад, бананы, орехи, цитрусовые, жирные сыры, алкоголь.

### 4.6 Медицинская реабилитация

Реабилитация направлена на улучшение функционирования и качества жизни.

1. постизометрическая релаксация, лечебная физкультура, дыхательные упражнения;
2. массаж шеи, воротниковой зоны и спины;
3. рефлексотерапия;
4. коррекция осанки, эргономика рабочего места.

Профилактика эффективна, если число дней с болью **через 3 месяца** сокращается **на 50% и более**.

Дополнительно оценивают приём обезболивающих, коморбидные нарушения и работоспособность. Без улучшения, а также при тяжёлом течении (хроническая мигрень, множественные коморбидные нарушения, ЛИГБ) пациента направляют в специализированный центр лечения головной боли.

---

## 5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

### 5.1 Диспансерное наблюдение

Всем пациентам показано динамическое наблюдение, в том числе с телефонными визитами.

1. разъяснение роли триггеров;
2. разъяснение факторов хронизации: стресса, депрессии, лекарственного абузуса, избытка кофеина, ожирения, синдрома апноэ во сне;
3. контроль эффективности и переносимости профилактики.

### 5.2 Показания к госпитализации

**Экстренная госпитализация в неврологическое отделение**

1. головная боль с изменением сознания;
2. с лихорадкой и менингеальными симптомами;
3. с нарастающей очаговой неврологической симптоматикой;
4. с нарастающей общемозговой симптоматикой;
5. «громоподобная» головная боль;
6. мигренозный статус.

**Плановая госпитализация**

1. прогрессирующая головная боль;
2. некупируемая головная боль;
3. тяжёлая ЛИГБ при злоупотреблении опиоидами, спазмолитиками, психотропными препаратами и анальгетиками в комбинации;
4. атипичная аура **более 1 часа**.

**Критерии выписки**

1. купирование головной боли;
2. уменьшение боли **до 3–4 баллов по ВАШ**;
3. успешная замена препарата злоупотребления на адекватную терапию.

---

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Мигрень» |
| Версия | 4-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024 |
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |
| Актуализация | По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года |
| Код в рубрикаторе | 295_4 · открыть текст КР ↗ |
| Разработчик | Всероссийское общество неврологов; Российское общество по изучению головной боли; Союз реабилитологов России |
| Пациенты | Взрослые |

### 6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.